Etat des lieux de la prise en charge du spina bifida chez les enfants au CHU Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023

Nom du présentateur : Caroline Yonaba/ Okengo

Caroline Okengo / Yonaba, Mouniratou Yonli, Sirinatou Ilboudo, Chantal Zoungrana, Sylvain Zabsore, Fla Koueta,

CHU Yalgado Ouedraogo

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- En 2020, les décès par malformations congénitales représentaient 2,6 % des décès au Burkina Faso .

- Les anomalies de fermeture du tube neural sont responsables d'une morbidité et d'une mortalité importantes. Parmi ces anomalies le spina bifida est le plus fréquent.

- Au CHUYO nous constatons une recrudescence des cas de spina bifida référés pour des complications médicales.

Introduction

- Les ressources limitées constituent un frein pour une PEC multidisciplinaire de cette malformation dans notre structure

- Les données sur le profil de ces enfants et leur devenir en pédiatrie demeurent insuffisantes d'où cette étude

Objectif

Décrire l'état des lieux de la prise en charge des cas de spina bifida au CHU Yalgado Ouédraogo

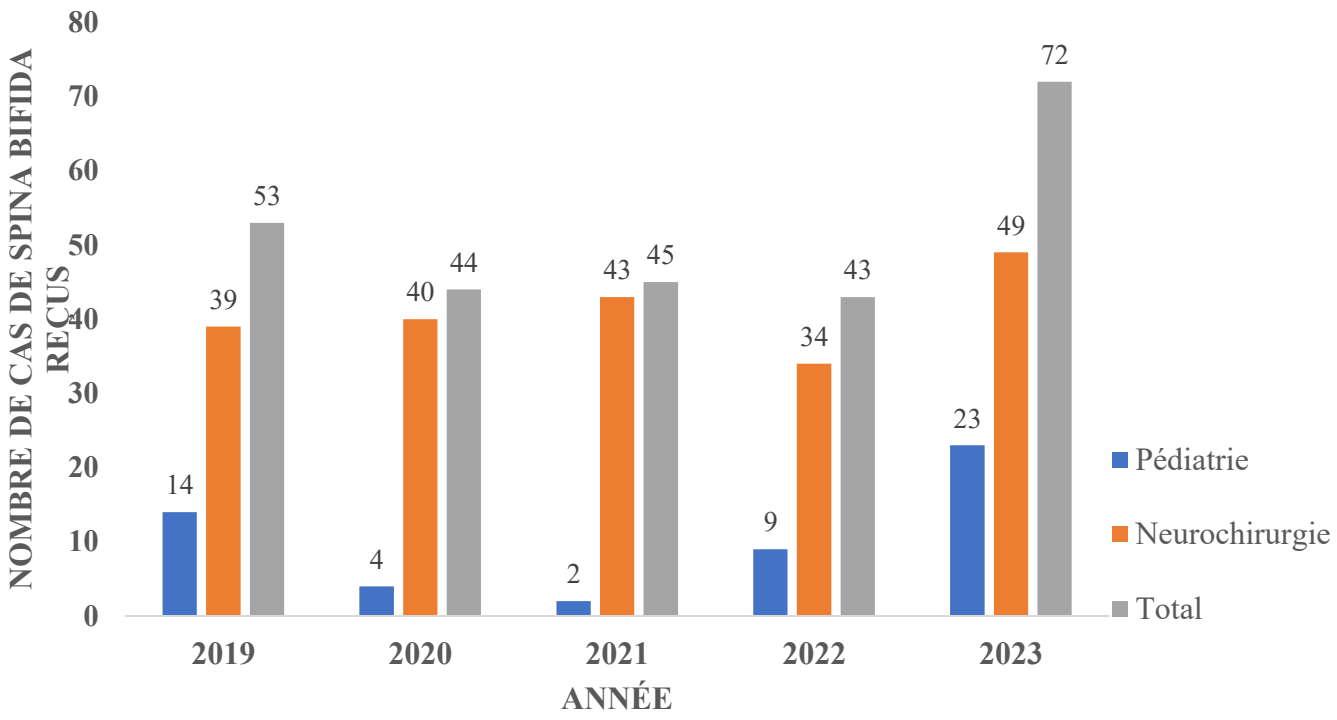
Matériel et méthode(s)

- **Cadre d'étude**: service de neurochirurgie et de pédiatrie du CHU Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou
- **Type et période d'étude**: transversale à collecte rétrospective sur les dossiers médicaux des enfants du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023
- **Critères d'inclusion**: Enfants (0-14 ans) admis pour spina bifida ayant un dossier ou une fiche de consultation

Résultats

Evolution des cas par année et par service

- Ont été inclus 218 enfants
  - ✓52 en pédiatrie
  - ✓205 en neurochirurgie
- Fréquence hospitalière
  - ✓ 0,4 en pédiatrie
  - ✓ 2% en neurochirurgie
  - ✓ 1 % au CHUYO
- Fréquence annuelle au CHUYO : 40 cas/an



Résultats

Age et sexe (N=218)

	Masculin	Féminin	Total
Age	n(%)	n(%)	n(%)
Nouveau-né	43	33	76 (35)
Nourrissons	73	66	139 (64)
Petit enfant	2	0	2 (0,9)
Grand enfant	1	0	1 (0,4)
Total	119 (55)	99(45)	218.(100)

âge moyen était de 4 mois

Résultats

Echographies obstetricales et prophylaxie antianémique

- ❑38 mères avaient réalisé l'échographie obstétricale
- ✓16 cas (42,1 %) d'hydrocéphalie
- ✓2 cas (5,3 %) de malformation du rachis associée à une hydrocéphalie.
- ❑Données sur prophylaxie Fer+ acide folique disponibles chez 131 parmi lesquels 19 (14,5%) pas de prise de cette prophylaxie

Résultats

Principaux motifs de consultation

Motif	Pédiatrie (n=52)
	n(%)
Malformation congénitale du rachis	**37 (71)**
Fièvre	**26 (50)**
Troubles neurologiques(deficits moteurs)	**15 (29)**
Troubles respiratoires	13 (25)
Altération de l'état général	11 (21)

Résultats

Caractéristiques de la malformation

Caractéristique	n	%
tuméfaction		
Etat		
Intacte	*178*	***82***
Rompue	*40*	*18*
Siège		
Lombosacré	*97*	***44***
Lombaire	*67*	*31*
Dorsolombaire	*36*	*16*
Autres	*18*	*8*

Anomalies associées

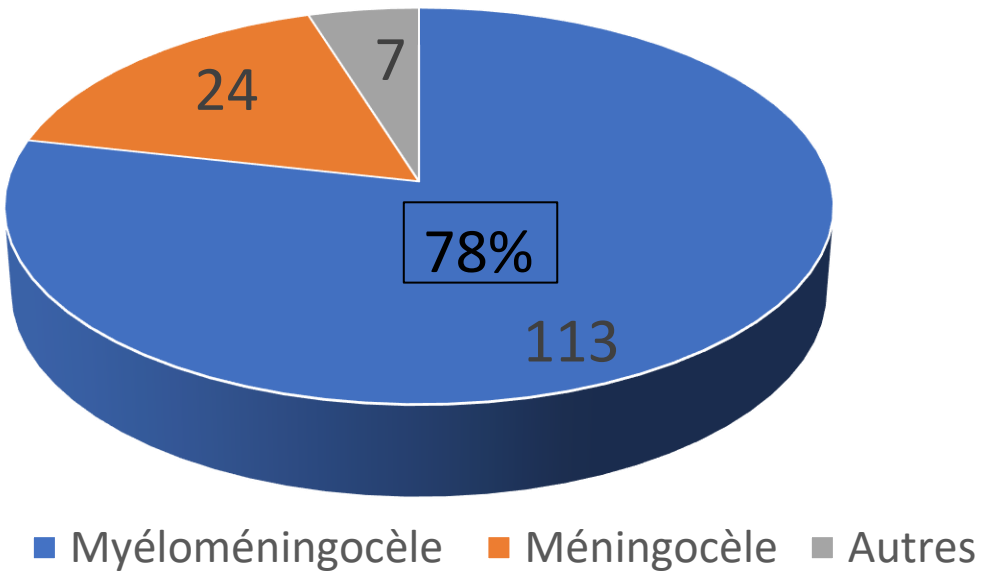
Anomalie associée	n	%
Macrocranie	**96**	**44**
Pieds bots varus équin	**50**	**23**
Dysmorphie faciale	4	2
Microcranie	3	1
Polydactylie	3	1
Genou recurvatum ou valgum	3	1
Paraplégie	**63**	**29**

Résultats

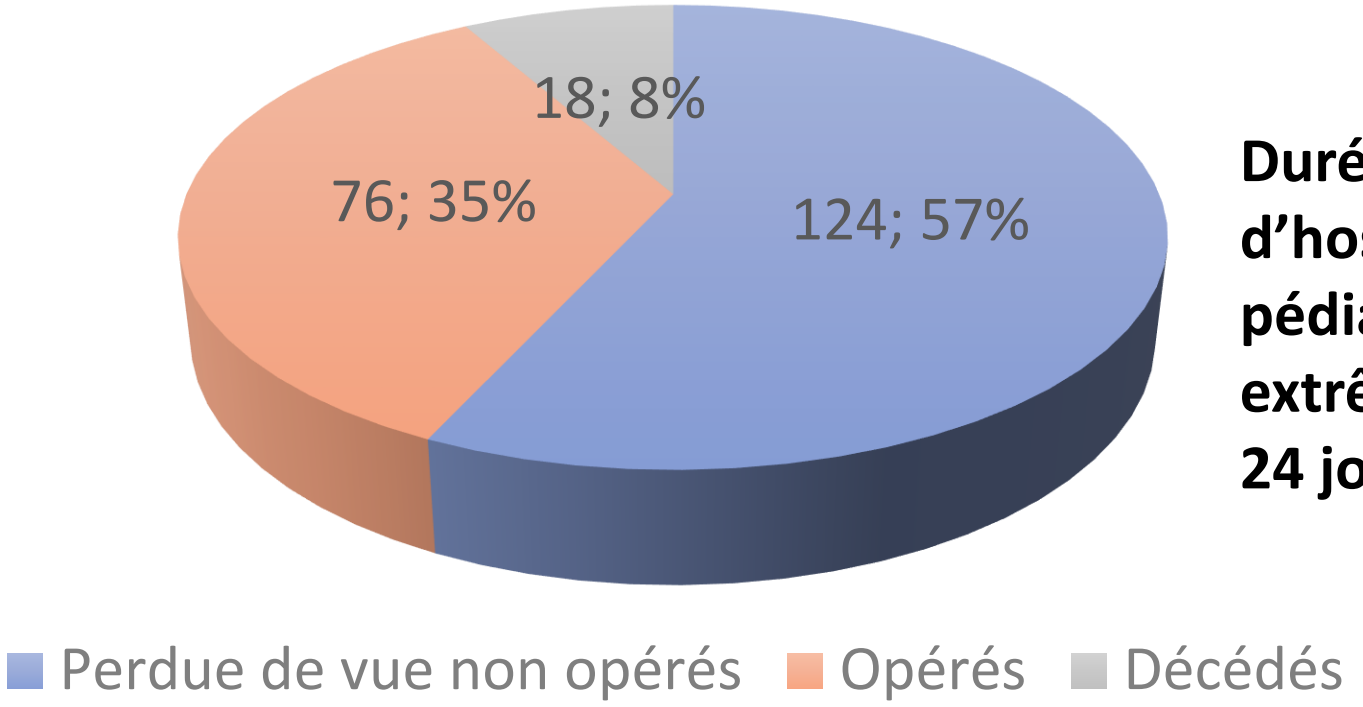
Pathologies associées (N=215)

Pathologies	n	%
Infection	**62**	**28**
Malformation d'Arnold	21	10
Chiari		
Malnutrition aigue	14	6
Souffrance néonatale	8	4
Malformation urogenitales	6	3
Malformation ano-rectale	4	2
Malformation cardiaque	2	1

Anomalies scanographiques du rachis (N=144)



Evolution



Durée moyenne d'hospitalisation en pédiatrie de 8 jours, extrêmes d'un jour et 24 jours

Conclusion

- Les cas de spina bifida sont en nette augmentation au CHU YO
- Le pronostic des enfants atteints de spina bifida demeure sombre
- La collaboration entre les deux services doit être renforcée
- Les études plus approfondies sont nécessaires pour comprendre les facteurs de risque liés à cette malformation dans notre contexte et les raisons d'abandon de soins dans un contexte de gratuité des soins

Merci pour votre attention